EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 80756
SERVICIO	: UTI HSC		
FECHA	: 2024-03-15 12:39:00		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA RAQUEL ARAVENA CONTRERAS			**RUN**	: 6.796.846-8
F.Nac	: 02-12-1953	**Edad**	: 70 AÑOS, 3 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: HUENUTIL CENTRO			**Comuna**	: NIQUEN
Previsión	: PRAIS	**Teléfono**	: 972046450		
Fecha Ingreso	: 2024-03-10	**Fecha Egreso**	: 2024-03-15 12:39:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.9-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia Respiratoria Aguda Parcial
a. EPD patrón UIP, exacerbada
b. Neumonía multilobar
2. Situs inversus
3. Hipertensión pulmonar
4. HTA
5. Tabaquismo cesado
6. Dislipidemia
7. Sospecha de hiperglicemia 2° a uso de corticoides

Procedimientos realizados en UTI: CNAF x 24 hrs, luego Oxigenoterapia por naricera. Instalación de línea arterial. Monitorización cardiaca continua. Kinesiterapia motora y respiratoria.

<u>DIAGNÓSTICOS CIE10</u>

1. J84.9-ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL, NO ESPECIFICADAA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. J84-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. Q89.3-SITUS INVERSUS. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. I27.2-OTRAS HIPERTENSIONES PULMONARES SECUNDARIAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA, portadora de EPD patron UIP (diagnosticado hace menos de 6 meses, en control con Broncopulmonar particular), en tratamiento con Budesonida 2 puff c/12 hrs, Bromuro de Ipratropio SOS, N acetilcisteina 600 MG 1-1. Relata cuadro de 1 semana de evolución de CEG, inapetencia, tos productiva y exacerbación de disnea. A su

legada a SU desaturando hasta 60%, taquicardica. Se apoya con O2, exámenes de laboratorio PCR 33, lactato 2.7, GB 15200, PAFI 161. Angiotc torax: negativo para TEP, se evidencia enf pulmonar difusa con extensa fibrosis establecida, focos de neumopatia multilobar con tendencia al relleno alveolar en lóbulo inferior derecho, cardiomegalia, signos de hipertensión pulmonar. GSA de control PAFI 173. Antigeno Sars cov 2 negativo. Se decide ingreso a UTI para apoyo con
CNAF. Presenta evolución favorable, con destete de CNAF a las 24 hrs., manteniéndose con aporte de FiO2 por naricera. Fue evaluada por Broncopulmonar, Dr. Pinochet, quien suspende indicación de n-acetilcisteína, se indica Oxigeno domiciliario y estudio inmunológico de EPID, el cual fue tomado el 14/03 en espera de resultado en Barnafi. En cuanto a exacerbación de EPID esta fue 2° a cuadro infeccioso respiratorio, sin aislamiento de microorganismo, pero con buena respuesta a tto. empírico antibiótico. Se traslapa a tto. atb oral para completar 14 días (con levofloxacino ya que no hay stock de amox/ac. Clavulánico en farmacia).
Durante hospitalización con glicemia de ayuna alteradas, sin requerimiento de refuerzo con insulina, pero en contexto de uso de corticoides. Una vez suspendidos, esperar 1 mes y realizar glicemia en ayuno ambulatoriamente en su CESFAM.
Se decide alta con HODOM para continuar rehabilitación pulmonar kinésica.

PLAN DE MANEJO:

HODOM para continuar KNT
O2 domiciliario
Control ambulatorio con broncopulmonar en CAE HSC

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen comun hiposódico
3. Apoyo con Oxigeno en domicilio por naricera 1 a 2 lts para saturar 88% (usar la menor cantidad posible)
4. Omeprazol 20 mg 1 casula antes desayuno vo
5. Levofloxacino 500 mg 1 comprimido al dia vo por 8 dias
6. Prednisona 20 mg al dia vo por 3 dias, luego disminuir a 10 mg por 2 dias y suspender
7. Budesonidea 2 puff c/12 hrs con aerocámara
8. Bromuro de Ipratropio 4 puff c/6 hrs con aerocámara
9. Salbutamol 2 puff c/6 hrs con aerocámara
10. Carvedilol 6.25 mg 1/2 comprimido c/12 hrs vo
11. Atorvastatina 20 mg 1 comprimido en la noche vo
12. Control con Broncopulmonar (Dr. Pinochet) en 1 mes
13. Pendiente rescatar resultados de estudio inmunológico en Barnafi (tomados el 14/03/24)
14. Mantener controles en su CESFAM correspondiente: realizar glicemias en 1 mes (descartar diabetes 2° a uso de corticoides)
15. HODOM: rehabilitación kinésica respiratoria y motora

EXÁMENES Y RESULTADOS

15/03/24 GSA: pH 7.49 pCO2 51,2 pO2 67,2 Bic 39.4 FiO2 24%
AngioTc torax: muestra focos de neumopatía multilobar con tendencia al relleno alveolar en lóbulo inferior derecho. Patron UIP

Control en: 30 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Ana Sepúlveda Venegas
MEDICO TRATANTE
13383078-2

JEFE SERVICIO